

KC桌面——外资精译

美洲医疗保健：制药：CMS专题讨论纪要——第47届年度全球医疗保健大会核心要点

结合本次大会，我们开展了例行的年中投资者情绪调查



图表 1

在第47届年度全球医疗保健大会上，我们与CMS副局长Stephanie Carlton及CMS办公厅主任兼立法办公室主任Rebekah Armstrong进行了专题讨论。

与会嘉宾就关键医疗议题阐述了观点，重点聚焦最惠国（MFN）药品定价，以及通过调整州政府定向支付和健康保险交易所等措施打击浪费、欺诈和滥用的行动。

下文将讨论核心要点。

核心要点

CMS优先事项的高层框架：CMS领导层将其近期议程围绕可负担性、可及性和系统现代化四大核心优先事项展开。首先，该机构旨在以患者为先的支付方身份运营，包括扩大技术应用以改善健康数据和医疗服务可及性。其次，CMS正在推进以预防为重点的战略（MAHA），同时投资于可及性模式和农村医疗，推动系统向更优结果和更主动的护理转型。第三，该机构正加大力度打击欺诈、浪费和滥用行为，尤其侧重于对欺诈性运营商的监管监督，与会嘉宾特别强调了针对家庭健康和临终关怀提供商的医疗补助注册冻结措施。最后，CMS将可负担性作为优先事项，最显著的是通过与制药商进行MFN药品价格谈判，以降低联邦医疗项目的整体成本。

州政府定向支付与医疗补助资金：关于近期对州政府定向支付的调整以及将责任转移至州医疗补助项目，与会嘉宾指出，他们正致力于加强项目完整性并重新平衡成本分担。该机构表示，联邦在医疗补助资金中的占比已从项目启动时的约60%上升至约70%。提供者税收机制和医疗补助扩展人群等项目被列为消耗更多联邦资金的领域，CMS认为这导致了联邦支出过度。CMS还计划通过逐步引入支付上限，使医疗补助报销标准更接近Medicare基准。政策方向强调各州在项目结构中承担更多财务责任并提高问责性。

药品定价：该机构强调，IRA首轮谈判已实现约20%的平均净节省，而本届政府主导的第二轮谈判折扣约为40%。与MFN相关的努力被描述为通过贸易动态等方式在全球范围内引入更广泛的定价压力，CMS将这些机制视为系统性降低药品成本的更广泛工具箱的一部分。与会嘉宾未就计划将MFN扩展至当前17家生物制药企业之外发表评论。

■ **ACA交易所：**关于交易所，该机构强调了对项目中严重欺诈和不当注册的担忧，并明确表示将通过剔除不合格参与者来加强项目完整性。CMS指出，新的支付规则包含一系列完整性措施，同时更广泛地努力改善各计划间的竞争，确保个人能够获得满足其需求的保险覆盖。